

肌肉骨骼性盆腔疼痛

WARWIKI

患者须知 · 来自肌肉、关节和神经的盆腔疼痛

有些盆腔疼痛并非来自膀胱或生殖器官，而是源于盆腔的肌肉、关节、神经和结缔组织——通常是盆底肌肉（pelvic floor muscles）过度紧张、无法放松所致。这种疼痛真实存在，十分常见，且可以治疗，即便影像检查和化验结果均正常。

关于这种疾病

盆底肌肉（pelvic floor muscles）可能变得紧绷或发生痉挛（spasm），就像身体其他部位的肌肉打结一样。常见表现包括：

- 盆腔、会阴、腰部或髋部的酸痛、压迫感或烧灼感
- 久坐、性交（性交痛）、使用卫生棉条或排便时疼痛
- 由紧张肌肉（而非膀胱本身）引起的尿急或尿频

病因

通常由多种因素共同导致：肌肉紧张或痉挛、既往受伤、手术或分娩史、体姿与日常习惯、精神压力（可导致不自觉收缩），有时还涉及盆腔神经受激惹。盆底往往是"短而紧"而非无力——这也是为什么强力凯格尔锻炼反而可能加重症状。

名词解释

盆底（Pelvic floor）

支撑盆腔器官的一组肌肉。

过度活跃／紧张的盆底

肌肉持续收缩、无法完全放松。

性交痛（Dyspareunia）

性活动时出现疼痛。

激痛点（Trigger point）

肌肉中的压痛硬结，可向其他部位放射疼痛。

盆底物理治疗（Pelvic-floor PT）

松解并重新训练这些肌肉的物理治疗（physical therapy）。

放松训练（Down-training）

学习放松（而非加强）过度紧张的盆底。

阴部神经（Pudendal nerve）

受到激惹时可引发疼痛的盆腔神经。

为什么检查正常，但我仍然疼痛？ 因为这种疼痛来自肌肉和神经，而非感染或肿瘤——后者才会在影像上显现。检查结果正常是好消息，说明问题是可治疗的肌肉问题，而非危险疾病。没有“影像证据”的疼痛同样真实存在。

如何诊断

- 详细了解疼痛的部位、时间及加重因素
- 体格检查，轻柔地**评估盆底肌肉**的压痛和紧张程度
- 通过简单检查排除其他原因（如感染等）

如何治疗（逐步方案）

- 1 **盆底物理治疗**是核心——包括手法松解、拉伸和放松训练（"down-training"）。
- 2 **自我护理**——热敷、温和活动、放松/呼吸练习、改善体姿，以及缓解便秘（constipation）和减少膀胱刺激因素。
- 3 **药物或注射治疗**——神经性疼痛药物或激痛点注射。
- 4 **管理压力与睡眠**，两者对肌肉紧张有显著影响。

日常管理

- 留意并主动释放日常的**不自觉收缩**（下颌、臀部、盆底）。
- 使用热敷和温和拉伸；避免长时间坐硬椅。
- 治疗通常需数周才能逐步见效——坚持很重要。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 新发**剧烈**盆腔疼痛或发热（fever）
- 新出现的肠道或膀胱功能改变，或腿部麻木／无力
- 跌倒或受伤后疼痛，或尿液、粪便中带血

需要记住的三件事

1. 盆腔疼痛常由过度紧张的盆底肌肉和神经引起——即便检查正常，疼痛也是真实的，且可以治疗。
2. 盆底物理治疗（以放松为目标，而非加强）是主要治疗手段，辅以自我护理、药物和压力管理。
3. 改善是循序渐进的。如出现新发剧烈疼痛、发热、腿部麻木／无力或肠道／膀胱功能改变，请及时就医。